

Comunicações de Acidente de Trabalho nas profissões da saúde em Campos dos Goytacazes, 2018-2025

Ryan de Paulo Santos

O trabalho é um processo social, econômico, político e técnico, historicamente determinado, e não apenas um local de exposição a riscos. Desde a Revolução Industrial, o modo de organizar a produção disciplina corpos e tempos e produz padrões específicos de adoecimento (OLIVEIRA, 2004). As teses do fim da centralidade do trabalho não se confirmaram: houve deslocamento da classe trabalhadora para o setor de serviços, no qual hoje se concentram precarização, terceirização e intensificação (LOURENÇO, 2012; ANTUNES, 2018). No Brasil, o campo da Saúde do Trabalhador constituiu-se como crítica à medicina do trabalho e à saúde ocupacional, ao afirmar a determinação social do processo saúde-doença e o processo de trabalho como categoria explicativa central (MENDES; DIAS, 1991). No setor saúde, essa perspectiva exige considerar que o trabalho produtor do cuidado se realiza sob divisão social e técnica do trabalho, relações desiguais de poder entre categorias, cargas de trabalho e desgaste, em serviços submetidos à reorganização gerencial flexível e à desproteção de parcela expressiva dos vínculos do Sistema Único de Saúde (SUS), estimada entre 30% e 50% (CECILIO; LACAZ, 2012). Este artigo analisa, à luz da formação histórico-social e econômica de Campos dos Goytacazes (RJ), o perfil das Comunicações de Acidente de Trabalho (CAT) vinculadas a empregadores do município entre as diferentes profissões da saúde, no período de 2018 a 2025.

Campos dos Goytacazes é o maior município fluminense em extensão (4.032,5 km²) e contava com 483.540 habitantes no Censo de 2022 (IBGE, 2026). Sua formação econômica assentou-se na agroindústria açucareira, organizada desde o período colonial sobre a grande propriedade e o trabalho escravizado e, posteriormente, sobre as usinas; ao longo do século XX essa base entrou em prolongada decadência e, a partir das décadas de 1980 e 1990, cedeu lugar à centralidade da exploração de petróleo da Bacia de Campos e das rendas petrolíferas (*royalties* e participações especiais) (SILVA; HASENCLEVER, 2019). Os dados oficiais evidenciam uma economia oscilante e dependente (Tabela 1): o produto interno bruto, a preços correntes, atingiu R\$ 58,4 bilhões em 2013, caiu para R\$ 23,9 bilhões em 2020 e retornou a R\$ 43,0 bilhões em 2023; a indústria, dominada pela atividade extrativa, respondeu por 66,4% do valor adicionado em 2013 e por 40,8% em 2020; a agropecuária, apesar da identidade agrária do discurso local, representou 1,0% em 2021, com a produção de cana reduzida de 4,28 milhões de toneladas em 2005 para 1,29 milhão em 2023 (IBGE, 2026). Silva e Hasenclever (2019) demonstram que o ciclo do petróleo elevou arrecadação e produto sem diversificação produtiva nem desenvolvimento social equivalentes; Martins, Hasenclever e Miranda (2024) mostram que o financiamento da saúde municipal acompanhou as flutuações das rendas petrolíferas entre 2009 e 2020, fragilizando a gestão da rede. Nesse mercado de trabalho, os serviços de saúde, polo regional de referência do Norte Fluminense, constituem espaço relevante de assalariamento, sobretudo feminino, estratificado por hierarquias de renda e de prestígio entre profissões, próximas do que a sociologia weberiana descreve como situações de classe e de estamento (LEMOS, 2012).

Tabela 1. Campos dos Goytacazes (RJ): síntese da formação econômica e social

Indicador	Valores	Fonte (IBGE/SIDRA)
População residente (2022); área; densidade	483.540 hab.; 4.032,5 km ² ; 119,9 hab./km ²	Censo 2022 (tabela 4714)
PIB a preços correntes	R\$ 58,4 bi (2013); R\$ 23,9 bi (2020); R\$ 43,0 bi (2023)	PIB dos Municípios (tabela 5938)
Participação da indústria (extrativa) no valor adicionado	66,4% (2013); 40,8% (2020)	PIB dos Municípios (tabela 5938)
Participação da agropecuária no valor adicionado (2021)	1,0%	PIB dos Municípios (tabela 5938)
Cana-de-açúcar: quantidade produzida	4,28 milhões t (2005); 1,29 milhão t (2023)	PAM (tabela 1612)

Fonte: elaborada pelo autor a partir de IBGE (2026); valores correntes, sem deflacionamento; interpretação histórica conforme Silva e Hasenclever (2019).

Método. Estudo teórico-conceitual e documental, apoiado em dados secundários públicos, com *pipeline* reprodutível, auditado e validado de forma independente (scripts, logs e testes automatizados acompanham o repositório do estudo). A base empírica foi reconstruída dos arquivos brutos dos dados abertos da CAT do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS): 58 arquivos,

competências de julho de 2018 a dezembro de 2025, totalizando 3.902.905 registros (BRASIL, 2026a). A importação foi feita por posição de coluna, porque a fonte apresenta quatro esquemas estruturais distintos e cabeçalhos duplicados (CBO, CID-10, CNAE e data do acidente); a codificação de caracteres foi detectada arquivo a arquivo; e o mês de referência administrativo (coluna 2) foi rigorosamente distinguido da data completa do acidente, única informação usada nas análises temporais. O recorte municipal exigiu, simultaneamente, código do município do empregador igual a 330100, extraído antes do hífen, e unidade federativa do empregador igual a Rio de Janeiro; municípios homônimos (Campos Novos, Campos do Jordão, Campos de Júlio, São José dos Campos, entre outros) foram identificados e excluídos, assim como 12 registros com unidade federativa divergente. Foram removidas 537 duplicidades exatas entre arquivos de cobertura sobreposta, demonstradas por resumo criptográfico (*hash* SHA-256) da linha bruta; duplicatas dentro de um mesmo arquivo foram mantidas e sinalizadas, por poderem representar eventos legítimos. A classificação ocupacional utilizou os códigos de seis dígitos da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO 2002), com dicionário auditado dos 459 códigos observados e três níveis de análise: universo principal das profissões da saúde; profissões multiprofissionais de atuação intersetorial (psicologia, serviço social, educação física e biologia), analisadas à parte; e trabalhadores de apoio em estabelecimentos de saúde, jamais somados às profissões da saúde. Registros sem código válido (184; 3,6%) foram mantidos em categoria própria e quantificados. Denominadores de força de trabalho foram extraídos do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES): profissionais por ocupação, em dezembro de cada ano, no município (BRASIL, 2026b); como o CNES abrange vínculos estatutários, autônomos e de pessoa jurídica, não cobertos pela CAT, tais denominadores sustentam apenas razões exploratórias de densidade de comunicação, e não medidas de incidência ou de risco. Todos os totais foram reproduzidos por rotina independente, com convergência integral; células com menos de cinco registros foram agregadas; as análises de sensibilidade abrangeram exclusão de 2025 (ano parcial, com dados até outubro), restrição aos meses de janeiro a outubro em todos os anos, exclusão de acidentes de trajeto, restrição a acidentes típicos e restrição a empregadores das divisões 86 e 87 da CNAE.

Resultados. Das 5.066 CATs vinculadas a empregadores de Campos dos Goytacazes entre 2018 e 2025, 1.144 (22,6%) correspondem ao universo principal das profissões da saúde, 26 às profissões multiprofissionais, 184 (3,6%) a registros sem CBO válido e 3.712 às demais ocupações (427 delas empregadas em estabelecimentos de saúde). A distribuição interna é fortemente assimétrica (Tabela 2): a enfermagem concentra 84,4% dos registros do universo principal, sendo 70,2% de técnicos e auxiliares e 14,2% de enfermeiros; seguem-se os técnicos e auxiliares de diagnóstico e laboratório (6,8%) e a fisioterapia (2,6%); a medicina responde por 1,0%. Predominam mulheres (85,7%), com idade mediana de 36 anos. Os acidentes típicos somam 81,9% e os de trajeto, 17,1%. Os ferimentos de punho e mãos lideram os diagnósticos (código S61 da CID-10: 25,1%; o dedo é a parte atingida em 43,9% dos registros), seguidos do contato ou exposição a doenças transmissíveis (Z20: 21,9%); agentes infecciosos e produtos biológicos respondem por 26,9% dos agentes causadores. Quase todos os empregadores pertencem às divisões 86 e 87 da CNAE (95,4%), com dominância hospitalar (classe 8610: 76,8%). O empregador emitiu 97,0% das CATs, com mediana de um dia entre o acidente e a emissão; houve um óbito registrado. Comunicações de doença relacionada ao trabalho somaram apenas 1,0%, mesmo com a pandemia dentro do período de análise (Figuras 1 e 2).

Tabela 2. Características das CATs das profissões da saúde, empregadores de Campos dos Goytacazes (RJ), 2018-2025 (n = 1.144)

Característica	n (%)
Técnicos e auxiliares de enfermagem	803 (70,2)
Enfermeiros	163 (14,2)
Técnicos e auxiliares de diagnóstico e laboratório	78 (6,8)
Fisioterapia	30 (2,6)
Técnicos e auxiliares de farmácia	20 (1,7)
Agentes comunitários de saúde e afins	14 (1,2)
Medicina	12 (1,0)
Demais categorias (farmácia, nutrição, odontologia e saúde bucal, fonoaudiologia, instrumentação cirúrgica; n<5 agregados)	24 (2,1)
Sexo feminino	980 (85,7)
Acidente típico; de trajeto; doença	937 (81,9); 196 (17,1); 11 (1,0)

Parte do corpo atingida: dedo	502 (43,9)
Agente causador biológico ou infeccioso	308 (26,9)
CID-10 S61 (ferimento de punho e mão); Z20 (exposição a doenças transmissíveis)	287 (25,1); 250 (21,9)
Empregador nas divisões CNAE 86 e 87 (na classe 8610, hospitalar)	1.091 (95,4); 879 (76,8)
CAT emitida pelo empregador; mediana acidente-emissão de 1 dia	1.110 (97,0)

Fonte: elaborada pelo autor a partir de Brasil (2026a). Idade mediana de 36 anos; sexo ignorado em 4 registros; um óbito registrado. Percentuais sobre o total do universo principal.

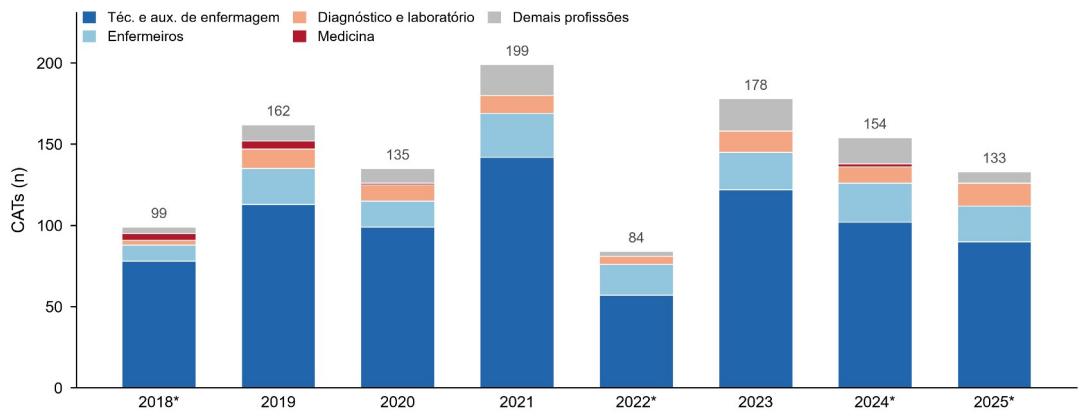


Figura 1. CATs de profissões da saúde (universo principal, n = 1.144) vinculadas a empregadores de Campos dos Goytacazes (RJ), por ano do acidente e categoria profissional, 2018-2025. Unidade: registros. Fonte: elaborada pelo autor a partir de Brasil (2026a). *Cobertura parcial ou irregular da fonte (2018: competências desde julho; 2022: carga irregular; 2024: setembro a dezembro atípicos; 2025: até outubro). Frequências de comunicação, não taxas de acidente.

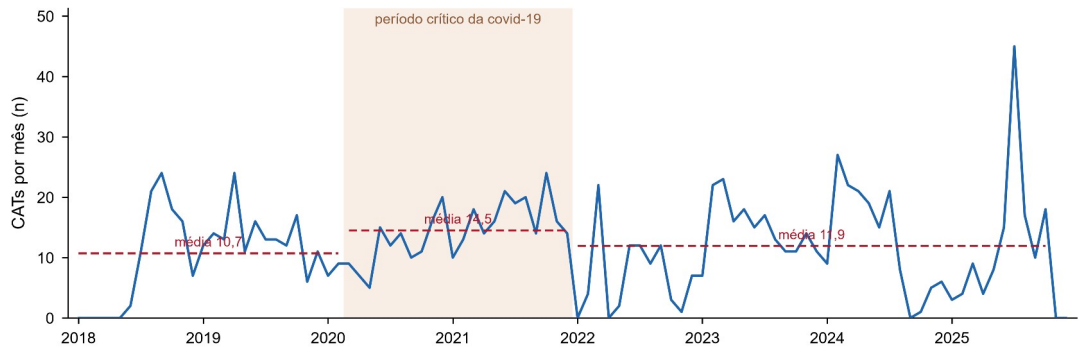


Figura 2. Distribuição mensal das CATs de profissões da saúde (universo principal, n = 1.144), empregadores de Campos dos Goytacazes (RJ), janeiro de 2018 a dezembro de 2025, com destaque para o período crítico da covid-19 (março de 2020 a dezembro de 2021) e médias mensais por período. Unidade: registros por mês. Fonte: elaborada pelo autor a partir de Brasil (2026a). As oscilações também refletem a cobertura da fonte (ver notas da Figura 1).

Discussão. A concentração dos registros na base técnica da enfermagem não deve ser lida como simples somatório de riscos biológicos ou ergonômicos: ela expressa a divisão social e técnica do trabalho em saúde, na qual a execução manual, contínua e corporal do cuidado (punção venosa, administração de medicamentos, manipulação de perfurocortantes, mobilização de pacientes) é delegada a categorias majoritariamente femininas, de menor renda e prestígio, submetidas a sobrecarga e intensificação, das quais deriva o desgaste (CECILIO; LACAZ, 2012; ANTUNES, 2018). A quase invisibilidade da medicina (12 CATs em oito anos, ante 1.360 a 1.702 médicos ativos no CNES) não autoriza concluir menor exposição: indica inserção por vínculos estatutários, autônomos e de pessoa jurídica, situados fora do emprego celetista coberto pela CAT, o que configura desigualdade de proteção e de reconhecimento institucional e reitera, no plano previdenciário, a estratificação de classe e de prestígio entre as profissões (LEMOS, 2012). Pela mesma razão, agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, majoritariamente vinculados à administração pública municipal, quase não aparecem na base (14 registros; nenhum agente de combate às endemias), sem que se possa inferir ausência de adoecimento. A elevação da média mensal de registros no período crítico da covid-19 (de 10,7 para 14,5, com 11,9 no período posterior) e o peso das exposições biológicas são compatíveis com a sobrecarga pandêmica descrita para os trabalhadores

da saúde, marcada por déficit de proteção e de reconhecimento (VEDOVATO et al., 2021); oscilações de cobertura da própria fonte, contudo, impedem qualquer atribuição causal (Figura 2). A baixíssima frequência de comunicações de doença (1,0%) reforça o diagnóstico de subnotificação seletiva: o sistema registra sobretudo a lesão aguda e visível, e não o adoecimento lento produzido pela organização do trabalho.

Os dados permitem descrever a estrutura interna das comunicações registradas: quem aparece, com que lesões, em que vínculos e em que estabelecimentos. Não permitem estimar incidência, prevalência ou risco ocupacional, pois as diferenças entre categorias podem refletir o tamanho das forças de trabalho, a composição e a formalização dos vínculos, a terceirização, a cobertura previdenciária, a cultura institucional de notificação e a subnotificação diferencial. A robustez interna dos achados é alta: a predominância da enfermagem e a hierarquia das categorias mantêm-se em todos os cenários de sensibilidade, com participação da enfermagem entre 84,4% e 86,3%. As razões exploratórias com denominadores do CNES (9.803 profissionais em 2018; 13.275 em 2025) reforçam o gradiente: nos anos de cobertura integral (2019 a 2021 e 2023) houve de 29,5 a 43,5 CATs por 1.000 técnicos e auxiliares de enfermagem ao ano, de 19,4 a 32,7 por 1.000 enfermeiros e, na medicina, no máximo 3,6 (valores suprimidos nos demais anos por contagens inferiores a cinco). Vínculos formais da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) por ocupação, município e ano permanecem como denominador prioritário para indicadores padronizados, condicionados à demonstração de compatibilidade entre numerador e denominador.

Considerações finais. Para a Vigilância em Saúde do Trabalhador e para a gestão municipal, os resultados indicam prioridades verificáveis: proteger a base técnica da enfermagem, núcleo do cuidado e dos registros, com ênfase em perfurocortantes e exposição biológica; enfrentar a subnotificação de doenças relacionadas ao trabalho e a invisibilidade de estatutários, terceirizados e informais, articulando CAT, RAIS, CNES e as notificações do SUS; qualificar o preenchimento dos registros, pois 3,6% não trazem código ocupacional válido, com concentração entre 2021 e 2023; e planejar a rede assistencial reconhecendo que seu financiamento oscila com as rendas petrolíferas (MARTINS; HASENCLEVER; MIRANDA, 2024) e que a proteção de quem cuida é condição de possibilidade do próprio cuidado.

Limitações. A CAT capta comunicações, e não a totalidade dos acidentes e adoecimentos; cobre essencialmente o emprego formal celetista, excluindo trabalhadores informais, autônomos e estatutários; não há denominadores plenamente compatíveis para o cálculo de incidência, e as razões com o CNES são exploratórias, porque o denominador inclui vínculos não cobertos pela CAT; a cobertura da fonte é parcial em 2018 (competências desde julho), irregular em 2022, atípica de setembro a dezembro de 2024 e incompleta em 2025 (dados até outubro), o que restringe comparações anuais; registros sem CBO válido podem subestimar as profissões da saúde entre 2021 e 2023; e o desenho descritivo e documental não permite inferência causal.

Referências

- ANTUNES, R. **O privilégio da servidão**: o novo proletariado de serviços na era digital. São Paulo: Boitempo, 2018.
- BRASIL. Instituto Nacional do Seguro Social. **Comunicações de Acidente de Trabalho (CAT)**: dados abertos, competências de julho de 2018 a dezembro de 2025. Brasília, DF: INSS, 2026a. Disponível em: <https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/inss-comunicacao-de-acidente-de-trabalho-cat>. Acesso em: 18 jul. 2026.
- BRASIL. Ministério da Saúde. DATASUS. **CNES: recursos humanos, profissionais, indivíduos, segundo CBO 2002, Rio de Janeiro**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2026b. Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br>. Acesso em: 18 jul. 2026.
- CECILIO, L. C. O.; LACAZ, F. A. C. **O trabalho em saúde**. Rio de Janeiro: Cebes, 2012.
- IBGE. **Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA)**: Censo Demográfico 2022 (tabela 4714); Produto Interno Bruto dos Municípios (tabela 5938); Produção Agrícola Municipal (tabela 1612). Rio de Janeiro: IBGE, 2026. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br>. Acesso em: 18 jul. 2026.
- LEMONS, M. R. Estratificação social na teoria de Max Weber: considerações em torno do tema. **Revista ILLUMINART**, Sertãozinho, ano 4, n. 9, p. 113-128, nov. 2012.
- LOURENÇO, G. G. O fim do fim do trabalho: uma crítica à chamada sociedade pós-industrial e sua relação com os movimentos de trabalhadores. **Primeiros Estudos**, São Paulo, n. 3, p. 104-121, 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.11606/issn.2237-2423.v0i3p104-121>. Acesso em: 18 jul. 2026.

MARTINS, S.; HASENCLEVER, L.; MIRANDA, C. A gestão da saúde à luz da instabilidade de financiamento e das propostas de governo. **Cadernos do Desenvolvimento Fluminense**, Rio de Janeiro, n. 27, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.12957/cdf.2024.87352>. Acesso em: 18 jul. 2026.

MENDES, R.; DIAS, E. C. Da medicina do trabalho à saúde do trabalhador. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 25, n. 5, p. 341-349, 1991. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0034-89101991000500003>. Acesso em: 18 jul. 2026.

OLIVEIRA, E. M. Transformações no mundo do trabalho, da Revolução Industrial aos nossos dias. **Caminhos de Geografia**, Uberlândia, v. 6, n. 11, p. 84-96, fev. 2004. Disponível em: <https://doi.org/10.14393/rcg51115327>. Acesso em: 18 jul. 2026.

SILVA, J. E. M. da; HASENCLEVER, L. Ciclo do petróleo e desenvolvimento socioeconômico no município de Campos dos Goytacazes (1999-2014). **Desenvolvimento em Questão**, Ijuí, v. 17, n. 46, p. 314-332, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.21527/2237-6453.2019.46.314-332>. Acesso em: 18 jul. 2026.

VEDOVATO, T. G.; ANDRADE, C. B.; SANTOS, D. L.; BITENCOURT, S. M.; ALMEIDA, L. P. de; SAMPAIO, J. F. da S. Trabalhadores(as) da saúde e a COVID-19: condições de trabalho à deriva? **Revista Brasileira de Saúde Ocupacional**, São Paulo, v. 46, e1, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2317-6369000028520>. Acesso em: 18 jul. 2026.